Navelbreuk buikwandbreuk

Voor de behandeling van jouw navelbreuk/buikwandbreuk word je binnenkort opgenomen. Hieronder lees je wat dit is, wat de oorzaken zijn en hoe de behandeling verloopt. Ook leest je over de voorbereiding op jouw opname en over de nazorg.

Wat is een navelbreuk/buikwandbreuk en wat is de oorzaak?

Als er een zwakke plek zit in het stevige laagje van de buikwand, ter plaatse van de navel (navelbreuk) of daarboven (buikwandbreuk) ontstaat er een zwelling. Deze is meestal weg te drukken en verdwijnt soms bij liggen. Bij staan of persen wordt de zwelling groter.

Wat zijn de klachten?

De zwelling kan ongemak geven en soms pijn veroorzaken. Bij inklemming (zeldzaam) ontstaat veel pijn. Dit is een acute operatie indicatie. Voor de behandeling van een navelbreuk of een buikwandbreuk is een operatie nodig en gebeurt onder narcose.

Hoe gaat de behandeling/operatie?

De breuk kan van buitenaf gerepareerd worden met een sneetje ter plaatse van de zwelling, waarbij de zwakke plek met stevige hechtingen of met een mat wordt verstevigd. Dit wordt uiteindelijk tijdens de operatie beslist, afhankelijk van hoe groot de zwakke plek is.

Ook kan de ingreep middels een kijkoperatie worden gedaan, waarbij de versteviging van binnenuit gebeurt met een matje. De chirurg zal tijdens het spreekuur met je bespreken wat voor jou de meest geschikte manier is.

Geen enkele ingreep is vrij van complicatierisico. Er kan een nabloeding optreden of een wondinfectie. Ondanks nauwkeurige reparatie kan de breuk terugkomen (recidief).

Er is ook een klein risico op letsel van buikinhoud zoals de darm. Als dat gebeurt dan kan er ontlasting in de buik lopen waarvan je ernstig ziek kan worden. De chirurg zal het risico op deze complicatie met je bespreken.

Hoe bereid je je voor op de operatie?

Bezoek aan het Opnamebureau

Na jouw bezoek aan de polikliniek ga je naar het Opnamebureau. Daar krijg je van de medewerker te horen hoe lang de wachttijd is tot de operatie. Ook krijg je een datum en tijd voor jouw afspraak voor het Preoperatief spreekuur anesthesiologie. Als de datum van je operatie gepland is word je gebeld door een medewerker van het Opnamebureau.

Preoperatief spreekuur anesthesiologie

Tijdens dit spreekuur bespreekt de anesthesioloog jouw gezondheidssituatie met je. Een anesthesioloog is een specialist die de verdoving (anesthesie) tijdens een operatie geeft. Ook komen

eventuele eerdere operaties ter sprake en jouw eventuele medicijngebruik. Soms is aanvullend onderzoek nodig.

Als je direct goedkeuring krijgt voor de operatie geeft de arts je een recept voor pijnstilling mee. Je kunt de pijnstillers alvast in huis halen.

Welke vorm van verdoving krijg je?

Voor de verdoving bij een navelbreuk/buikwandbreuk zijn er twee mogelijkheden.

- narcose: algehele verdoving, je 'slaapt'
- ruggenprik: regionale verdoving (hierbij wordt het onderlichaam verdoofd).

De anesthesist bepaalt welke vorm voor je het beste is tijdens de operatie.

Bij de operatie zijn beide verdovingsmethoden mogelijk.

Uitgebreide informatie over de (vorm van) verdoving vind je in de folder ' Anesthesiologie' . Deze krijg je bij jouw bezoek aan het Opnamebureau.

Gebruik je bloedverdunners?

Als je bloedverdunners gebruikt zal de chirurg tijdens het bezoek op het spreekuur, bespreken of je tijdelijk moet stoppen met de bloedverdunners. Mocht je bij de trombosedienst onder controle staan, dan kan het zijn dat je tijdelijk een ander middel krijgt rond de operatie. Je krijgt hier dan zo nodig een recept voor. Vergeet je niet de trombosedienst hiervan op de hoogte te stellen? Ascal mag je meestal wel gebruiken.

Regel opvang na de operatie

Na de operatie mag je de eerste 24 uur niet alleen zijn. Regel hulp voor jouw opname. Deze persoon kan je bijstaan als dat nodig is.

Als het je echt niet lukt om opvang te regelen voor de eerste 24 uur na de ingreep, dan kan de ingreep in dagbehandeling niet doorgaan. Neem dan contact op met het Opnamebureau.

Regel vervoer

Na de operatie mag je 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer of machines bedienen. Regel dus ook vooraf vervoer, bij voorkeur met een auto of taxi.

Ontharen

De week voor de ingreep mag je jouw onderbuik en lies niet ontharen. Door ontharen kunnen kleine wondjes ontstaan die kunnen ontsteken. Dit kan een wondinfectie veroorzaken.

Telefonisch contact over tijdstip opname

Als de opnamedatum bekend is, belt het Opnamebureau jou 2 dagen voordat je wordt opgenomen. Je hoort dan hoe laat en waar je zich op de opnamedag moet melden.

De dag vóór jouw opname

Voorbereiding

Nuchter zijn

Voor de operatie **moet** je nuchter zijn. Dat betekent dat je de avond voor de operatie vanaf 24.00 uur (middernacht) niets meer mag eten. Drinken van heldere dranken zoals water, (aanmaak) limonade en thee zonder melk is toegestaan tot 2 uur voor jouw opnametijd.

Gebruik je medicijnen?

Als je medicijnen gebruikt, heeft de anesthesioloog jouw verteld welke medicijnen je met een slokje water in mag nemen. Neem een lijstje mee van de medicijnen die je gebruikt. Zorg ook dat je voor de eerste 24 uur jouw eigen medicijnen meeneemt naar het ziekenhuis.

De dag van de operatie

Ontvangst op de afdeling

Meld je op de afgesproken tijd op de afdeling. Een verpleegkundige ontvangt je en begeleid je naar je kamer. De verpleegkundige stelt nog een aantal vragen. In elk geval vraagt zij je wie jouw contactpersoon is en welke medicijnen je gebruikt. Het is prettig als je het telefoonnummer van jouw contactpersoon hebt.

Ook vertelt de verpleegkundige hoe laat je ongeveer naar huis kunt. Zo kan degene die je begeleidt daar rekening mee houden.

Je krijgt een bandje om je pols met jouw persoonsgegevens.

Wachten op de operatie

Om de tijd tot de operatie door te komen is het prettig om bijvoorbeeld een tijdschrift mee te nemen. Je kunt ook televisie kijken en je hebt toegang tot internet of wifi.

Voorbereiding op de operatie

Een medewerker van het OK Complex geeft aan als je aan de beurt bent.

Je krijgt een operatiehemd aan. Jouw eventuele bril, gehoorapparaat en/of kunstgebit blijven op de afdeling.

De verpleegkundige vraagt je naar het toilet te gaan om te plassen, zodat uw blaas leeg is. Hierdoor kan de operatie beter worden uitgevoerd en kun je na de operatie ook makkelijker plassen.

Om pijn te voorkomen na de operatie krijg je alvast een tablet paracetamol.

Het OK Complex

Een verpleegkundige van de afdeling brengt je in een bed naar het OK Complex. Een anesthesiemedewerker ontvangt je daar. Je krijgt een slangetje (infuus) in een bloedvat van jouw arm of handrug. Dit is om vocht of medicijnen te kunnen geven. Ook krijg je plakkers op je borst die via draden zijn aangesloten op een bewakingsapparaat. Dit apparaat meet je bloeddruk en registreert je hartritme. Op een van de vingers krijg je een soort knijpertje dat uw zuurstofgehalte meet.

Bij een operatie in de lies krijg je in geval van een regionale verdoving een ruggenprik. Daarna word je naar de operatiekamer gebracht.

Op de operatiekamer word je over getild op de operatietafel. Jouw armen komen naast je lichaam te

liggen en worden ingepakt.

Na de ingreep

Na de operatie brengen de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker je naar de uitslaapkamer. Dat is een aparte ruimte waar verpleegkundigen erop toezien dat je goed bijkomt van de operatie. Ook hier ben je aangesloten op de bewakingsapparatuur. De verpleegkundige van de uitslaapkamer vraagt je of je pijn heeft of misselijk bent. Je krijgt daar dan medicijnen voor.

Terug naar de afdeling

Als de controles goed zijn, word je teruggebracht naar de afdeling. De verpleegkundige geeft je daar de nodige zorg. Je krijgt pijnstillers, ook als je op dat moment (nog) geen pijn heeft. Door de pijnstillers op vaste tijden in te nemen is de pijn doorgaans beter te verdragen. Waarschuw de verpleegkundige als de pijnstillers onvoldoende resultaat hebben.

Je mag weer drinken en eten. Jouw infuus wordt verwijderd. Voor je naar huis gaat moet je een keer geplast hebben.

Leefregels na de operatie

Wanneer kun je naar huis?

Als alles in orde is, overlegt de verpleegkundige met jou en je contactpersoon wanneer je naar huis kunt.

Tillen

De eerste 4 weken mag je niet zwaar tillen. Tillen is wel toegestaan, maar houd rekening met je klachten.

Dieet

Je mag eten wat je wilt, mits je niet misselijk bent.

Douchen

De dag na de operatie mag je douchen.

Activiteiten

Normale activiteiten kunnen een dag na de ingreep weer worden hervat, als je zelf het gevoel hebt fit genoeg te zijn. “Wat kan mag, luister naar jouw lichaam.” Je kunt meestal na 1 week weer aan het werk, tenzij je zwaar werk doet, dan kun je het beste een week of 3-4 wachten en daarna de belasting op het werk opbouwen. Je mag na 6 weken weer sporten.

Wondjes

De pleister mag je na 24 uur verwijderen. Als de wond nog lekt, mag je een nieuwe pleister plakken. Als de wond droog is, is een pleister niet meer nodig.

Poliafspraak

In principe krijg je een afspraak mee voor 3-4 weken na de operatie, dit kan vaak ook telefonisch. Bij niet oplosbare hechtingen worden deze na 10 dagen verwijderd.

Wanneer neem je telefonisch contact op?

Heb je vragen over jouw opnamedatum?

Neem dan contact op met het Opnamebureau tijdens het telefonisch spreekuur. Dit kan elke werkdag tussen 14.00 en 16.30 uur. Je belt hiervoor het nummer (070) 210 2839.

Heb je problemen binnen kantoortijden:

- tussen 8.30 en 16.30 uur
- Poli Chirurgie Zoetermeer (079) 346 2885
- Poli Chirurgie Den Haag (070) 210 2735

Heeft u (dringende) problemen buiten kantoortijden:

- SEH Zoetermeer (079) 346 2539
- SEH Den Haag (070) 210 2060

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.